Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo

Av. Unisinos, 99 - Bairro: São João Batista - CEP: 93022414 - Fone: (51) 3590-1299 - Balcão Virtual (Whatsapp): 51 98035.2866 - Email: frsaoleo5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5024735-48.2023.8.21.0033/RS

AUTOR: CAROLINA STRACK PADILHA

RÉU: BRADESCO SAUDE S/A

SENTENÇA

I. Relatório:

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por **CAROLINA STRACK PADILHA** em face de **BRADESCO SAUDE S/A**, ambos já qualificados. Narrou ser portadora de esclerose múltipla (CID G35) em estágio grave, com múltiplas lesões cerebrais e sequelas motoras irreversíveis. Relatou que tratamentos anteriores falharam e que a alternativa terapêutica seguinte, *Natizumabe*, foi descartada devido ao alto risco de desenvolvimento de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva. Diante desse quadro, sua médica assistente prescreveu o medicamento *Kesimpta* (Ofatumumabe) como única opção viável para o controle da doença. Contudo, ao solicitar a cobertura do fármaco, a ré negou o pedido, sob a justificativa de que não foram atendidas as diretrizes de utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Discorreu sobre o direito que entende aplicável ao caso. Requereu, em sede de tutela de urgência, a disponibilização no medicamento. Ao final, requereu a confirmação da liminar e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Concedida a gratuidade da justiça, deferida a tutela de urgência e determinada a citação da parte ré (evento 3, DESPADEC1).

Citada, a ré apresentou contestação (evento 24, CONT1). Preliminarmente, impugnou o valor da causa. No mérito, sustentou a legalidade da negativa, afirmando que o medicamento *Kesimpta* (Ofatumumabe) não está previsto na Diretriz de Utilização (DUT) 65.13 da ANS para o tratamento da esclerose múltipla. Argumentou pela taxatividade do rol da ANS, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Rechaçou o pedido de danos morais. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Réplica ao evento 27, RÉPLICA1.

Posteriormente, a ré informou o cancelamento do contrato de plano de saúde da autora, a pedido da empresa estipulante, com vigência a partir de 01/01/2024, requerendo a revogação da liminar (evento 29, PET1).

A autora manifestou-se (evento 32, PET1), esclarecendo que não houve cancelamento, mas sim a portabilidade de seu plano para uma nova apólice, na condição de dependente de seu cônjuge, dentro do mesmo grupo econômico da ré. Informou, ainda, que mesmo após a portabilidade, a operadora continuou a negar o tratamento, e que o descumprimento da ordem judicial estava agravando seu quadro clínico.

A decisão do evento 38, DESPADEC1 reiterou a ordem liminar, reconhecendo a continuidade da relação contratual dentro do mesmo grupo econômico, e fixou multa diária de R$ 5.000,00 em caso de novo descumprimento.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (evento 54, DESPADEC1), as partes requereram o julgamento antecipado do feito (evento 59, PET1).

É o relatório.

Decido.

II. Fundamentação:

Analisando os autos, vejo que o feito tramitou regularmente, não havendo quaisquer nulidades a ser declaradas ou atos anuláveis pendentes de cognição do juízo. Em que pese a regularidade do feito, existem questões processuais pendentes que devem ser solucionadas antes de dar início ao julgamento do mérito.

Da impugnação ao valor da causa:

A ré impugna o valor atribuído à causa, sustentando que a obrigação de fazer não possui conteúdo econômico imediato. No entanto, o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

No caso, o proveito econômico pretendido pela autora corresponde ao custeio do tratamento, cujo valor anual foi estimado na inicial. Assim, o valor atribuído à causa (R$ 162.240,00) reflete adequadamente o benefício econômico perseguido.

Rejeito, pois, a impugnação.

Da relação jurídica e da legislação aplicável:

A relação jurídica estabelecida entre o beneficiário de plano de saúde e a operadora é, inequivocamente, uma relação de consumo, sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência, conforme consolidado na Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

Além da legislação consumerista, a matéria é regulada pela Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e pelas resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A interpretação das cláusulas contratuais, portanto, deve ser pautada pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, da interpretação mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o artigo 47 do CDC, mormente em contratos de adesão como o presente. Trata-se de contrato de trato sucessivo e de longa duração, cujo objeto principal é a garantia da saúde e da vida do beneficiário, bens jurídicos de máxima importância.

Do mérito:

A controvérsia central limita-se na legalidade da recusa da operadora de saúde em custear o tratamento com o medicamento *Kesimpta* (Ofatumumabe), prescrito à autora para tratamento de esclerose múltipla.

A ré fundamenta sua negativa na ausência de previsão específica do fármaco na Diretriz de Utilização (DUT) 65.13 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Ocorre que o debate acerca da natureza do Rol da ANS, após intensa mobilização social e legislativa, culminou em uma alteração legislativa de suma importância, que pacificou a questão em favor da proteção do consumidor e da garantia ao tratamento de saúde.

Refiro-me à Lei n.º 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei n.º 9.656/98, para estabelecer critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no referido rol.

> *Art. 10. [...]*
>
> *§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***

A nova legislação, portanto, superou a controvérsia sobre a taxatividade do rol, estabelecendo que este constitui uma **referência básica de cobertura**, e não um limite intransponível.

A recusa de cobertura de tratamento não listado no rol somente é lícita se não preenchidos os critérios alternativos previstos no § 13, quais sejam, a comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou a recomendação de órgãos técnicos renomados.

Nesse sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO – TEA. I. CASO EM EXAME:Apelação cível interposta pelo IPÊ Saúde contra sentença que condenou a autarquia a fornecer tratamento multidisciplinar à parte autora, acometida por Transtorno do Espectro do Autismo, mediante coparticipação financeira do usuário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:Há duas questões em discussão: (i) a alegação de que o tratamento solicitado não consta no rol de cobertura do IPÊ Saúde; (ii) a possibilidade de limitar o tratamento nos termos do rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR: Fornecimento de tratamento multidisciplinar fora dos protocolos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento da autarquia previdenciária não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários. Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão nos protocolos/listas da Autarquia não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado.* ***Ao depois, a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS ampliou as coberturas obrigatórias para tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, tornando obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente.*** *Hipótese dos autos em que restou comprovado através de atestados fornecidos por profissionais especializados a necessidade e a urgência no tratamento multiprofissional solicitado pela parte autora, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou que a Autarquia forneça o tratamento multidisciplinar postulado, independentemente de constar ou não em seus protocolos ou listas. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 15.145/2018, arts. 1º, 2º e 4º; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 53575308520238217000, Rel. Miguel Ângelo da Silva, j. 22-04-2024; TJRS, Apelação Cível, Nº 50016887320218210111, Rel. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 10-04-2024. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50017825520248210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 30-07-2025) (grifei)*

A análise dos autos revela, de forma inconteste, a gravidade do quadro clínico da autora. Os laudos médicos e exames de imagem acostados (evento 1, LAUDO10, evento 1, OUT17) demonstram que a autora é portadora de esclerose múltipla, uma doença neurológica crônica, autoimune e progressiva, que se manifesta em seu caso de forma particularmente agressiva, com a presença de múltiplas lesões cerebrais e medulares e com a ocorrência de surtos que resultam em sequelas motoras definitivas.

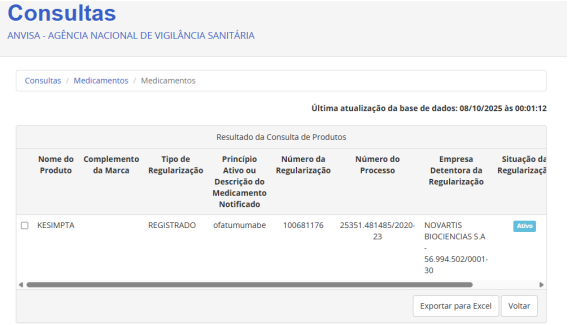
O histórico terapêutico da paciente evidência a falha dos tratamentos convencionais anteriormente utilizados, como o Acetato de Glatiramer e o Fumarato Dimetila, que não foram capazes de conter a progressão da doença.

Ademais, restou comprovada a contraindicação do uso do Natalizumabe, outra opção terapêutica, em razão do alto risco de desenvolvimento de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva, uma complicação potencialmente fatal.

Nesse sentido, o tratamento prescrito preenche inequivocamente o requisito do inciso I do § 13 do artigo 10 da Lei n.º 9.656/98.

Portanto, se o contrato de plano de saúde oferece cobertura para a patologia que acomete o beneficiário – o que é incontroverso no caso, pois a esclerose múltipla está listada na Classificação Internacional de Doenças (CID) –, não pode a operadora limitar as modalidades terapêuticas que serão utilizadas para o tratamento, sob pena de esvaziar a própria finalidade do contrato, que é a de garantir a assistência à saúde do consumidor.

Ademais, o medicamento possui registro na ANVISA, não se tratando, portanto, de tratamento experimental, cuja exclusão de cobertura é permitida por lei.



Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Última atualização da base de dados: 08/10/2025 às 00:01:12

Resultado da Consulta de Produtos

Nome do Produto	Complemento da Marca	Tipo de Regularização	Princípio Ativo ou Descrição do Medicamento Notificado	Número da Regularização	Número do Processo	Empresa Detentora da Regularização	Situação da Regularizaçã
KESIMPTA		REGISTRADO	ofatumumabe	100681176	25351.481485/2020-23	NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A - 56.994.502/0001-30	Ativo

Exportar para Excel Voltar

Além disso, cabe mencionar que a escolha da terapia mais adequada cabe exclusivamente ao médico que acompanha o paciente, e não à operadora de saúde.

Nesse sentido:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS.* ***PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCLEROSE MÚLTIPLA*** *PRIMÁRIA PROGRESSIVA.* ***OFATUMUMABE. INTRAVENOSO EM AMBIENTE HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. COBERTURA DEVIDA.*** *TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS. 1. CONSIDERANDO A INDICAÇÃO MÉDICA E A PREVISÃO DO TRATAMENTO MÉDICO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE, NECESSÁRIA SE MOSTRA A COBERTURA, NÃO SERVINDO EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS PONTUAIS NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO,* ***DESTACANDO-SE QUE CABE AO MÉDICO DEFINIR OS TRATAMENTOS MAIS ADEQUADOS AO PACIENTE.*** *2. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC, IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA.(Agravo de Instrumento, Nº 53625912420238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 13-03-2024) (grifei)*

A recusa da ré, portanto, revela-se abusiva, pois viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, colocando a consumidora em desvantagem exagerada e esvaziando o próprio objeto da avença, que é a proteção da saúde.

No que tange à alegação de cancelamento do contrato, os documentos juntados (evento 36, OUT3 e evento 36, OUT4) demonstram que ocorreu uma portabilidade para outra apólice dentro do mesmo grupo econômico (Bradesco Saúde).

Importante ressaltar que a utilidade do provimento jurisdicional persiste, seja para declarar a ilegalidade da conduta original, seja para resolver os pedidos acessórios de condenação em danos morais e na multa por descumprimento, que são consequências diretas da resistência da ré.

O fato de a execução direta da obrigação de fazer, nos moldes originalmente pleiteados sob a égide do contrato primitivo, ter se tornado desnecessária não implica a perda do interesse processual.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJRS:

> *APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. COBERTURA DEVIDA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.* ***PRELIMINARES DA APELAÇÃO DA RÉ DE PERDA DO OBJETO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS, UMA VEZ QUE O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL****, E A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL MOSTROU-SE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. O CERNE PROCESSUAL CONSISTE EM EXAMINAR AS PRETENSÕES DA AUTORA REFERENTES AO CUSTEIO DO TRATAMENTO PARA CÂNCER MAMÁRIO, À RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, AO AFASTAMENTO DO PERCENTUAL DE COPARTICIPAÇÃO E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, EM RAZÃO DE SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE CARÊNCIA CONTRATUAL, REVELA-SE*

ABUSIVA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 12, V, "C", DA LEI N.º 9.656/98. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ENSEJA O AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA E OS CUSTOS DO TRATAMENTO. RELATIVAMENTE AOS DANOS MORAIS, A NEGATIVA ABUSIVA DA OPERADORA VIOLOU OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, DEVENDO SER MAJORADA A INDENIZAÇÃO AO PATAMAR DE R$ 18.000,00, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E OS PARÂMETROS USUALMENTE FIXADOS POR ESTA CÂMARA. PRELIMINARES RECURSAIS REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50053751020238210072, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 21-05-2025)(grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. RECUSA DE CUSTEIO. PEMBROLIZUMAB. PERDA DE DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer em que postula a parte autora a condenação da ré ao dever de cobertura de medicamento antineoplásico. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu perda de objeto diante da portabilidade contratual realizada pela parte autora; e (ii) saber se devida a cobertura contratual do medicamento. III. Razões de decidir 3. Perda de objeto. ***Não há se falar em extinção da ação pela perda de objeto diante da portabilidade contratual para outra operadora de saúde, pois a presente demanda deverá abarcar o prazo contratual até que efetivada portabilidade, período o qual o interesse de agir é latente, inclusive, frente a negativa de cobertura da ré.*** *4. Mérito. A controvérsia objeto da lide - dever (ou não) de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento ou procedimento indicado pelo médico assistente - encontrava amplo espaço para divergência jurisprudencial em todos os âmbitos do Poder Judiciário, o que também refletia nos julgados proferidos pelo STJ. Entretanto, em recente julgado, a Seção competente ao julgamento da matéria, compreendida pela Terceira e Quarta Turmas do Tribunal da Cidadania, fixou teses sobre a a matéria, dentre outras, indicando que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pode ser relativizado. 5. É indevida a recusa da operadora de plano de saúde em custear antineoplásico domiciliar de uso oral. É nula a exclusão contratual de tratamento domiciliar de doença coberta pelo plano de saúde, utilizando medicamento antineoplásico, a vista da necessidade do tratamento, sob pena de praticar fato atentatório à função social do contrato de plano de saúde, que consiste justamente em oferecer cobertura para tratamento das doenças abrangidas pelo contrato. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Unânime. Dispositivos relevantes citados: arts. 1º, 6º e 196 da CF. Arts. 10, 22 da Lei nº 9.656/1988. Art. 47 e 51 do CDC. Jurisprudência relevante citada: EREsp nº 1.886.929-SP. (Apelação Cível, Nº 51589358820238210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 31-07-2025)(grifei)*

Da multa pelo descumprimento da liminar:

A tutela de urgência foi deferida no evento 3, DESPADEC1, em 05/10/2023, determinando-se o cumprimento da obrigação em 48 horas. Diante do descumprimento noticiado pela autora, este Juízo, na decisão do evento 38, DESPADEC1 (proferida em 19/02/2024, após novas petições da autora informando a persistência da negativa), fixou multa diária de R$ 5.000,00.

A ré foi intimada de tal decisão (evento 39), mas, ainda assim, a autora continuou a reportar o não fornecimento do medicamento. Apenas ao evento 62, PET1, em 22/10/2024, a ré informou que o medicamento estaria autorizado.

As astreintes têm natureza coercitiva, visando compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer. A resistência da ré em cumprir a ordem judicial, mesmo após a fixação expressa da multa, é manifesta.

As dificuldades operacionais alegadas, como a migração de contrato, não podem servir de escudo para o descumprimento de uma determinação judicial que versava sobre a saúde e a vida de uma paciente com doença grave e progressiva. Cabia à ré, como grande empresa do setor e parte do mesmo grupo econômico que passou a gerir o novo plano, ter adotado as providências internas para garantir a continuidade do tratamento sem interrupções, em estrita obediência ao comando judicial.

A multa, portanto, é devida.

O marco inicial para a incidência da multa é o término do prazo de 5 dias concedido na decisão do evento 54, DESPADEC1. O termo final, por sua vez, deve ser a data em que a ré comprovou, de forma inequívoca, a efetiva liberação e o início do fornecimento do medicamento, o que, nos autos, só se pode aferir a partir da petição do evento 62, PET1, de 22/10/2024.

Contudo, conforme disposto no art. 537, §1º, do CPC, *"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva".*

De mesmo modo, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o valor total da multa pode e deve ser limitado pelo juiz, de ofício, a um patamar razoável e proporcional.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. FORNECIMENTO DE LEITO PSIQUIÁTRICO COM ELETROCONVULSOTERAPIA. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. I. CASO EM EXAME.Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que manteve o arbitramento de multa diária em caso de descumprimento da medida liminar para fornecimento de leito psiquiátrico com eletroconvulsoterapia a adolescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.Há duas questões em discussão: (a) a possibilidade de revogação da multa cominatória fixada pelo juízo de origem; (b) a alegação de impossibilidade material de cumprimento imediato da obrigação pela indisponibilidade de leito com eletroconvulsoterapia. III. RAZÕES DE DECIDIR.1. A multa cominatória fixada com base em sentença proferida em Ação Civil Pública não faz coisa julgada material, podendo ser modificada pelo juiz a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, caso se mostre insuficiente ou excessiva. 2. ***O Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador pode modificar o valor das astreintes a qualquer tempo, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, ressalta-se que o STJ também possui o entendimento de que, após uma revisão e alteração do valor da multa, não é possível novas modificações, preservando a segurança jurídica e evitando que o devedor recalcitrante se beneficie de sucessivas reduções, operando-se a preclusão consumativa.*** *Na hipótese, trata-se de situação de não incidência de preclusão temporal, de forma que o valor da multa pode ser modificado a qualquer tempo. 3. Assim, é possível no caso em tela a modificação do valor da multa, mormente demonstrado o cumprimento superveniente da obrigação e que a impossibilidade inicial de cumprimento ocorreu pela indisponibilidade de leito com realização de eletroconvulsoterapia (ECT). Ademais, o leito psiquiátrico foi disponibilizado em 14 dias após intimação da responsável legal pela Central de Leitos do Município. Não houve, assim, inércia, negligência, ou recalcitrância no cumprimento da ordem judicial pelo agravante. 4. Tratando-se de ação autônoma, de parte determinada, que não guarda relação com a ação civil pública proposta pelo Ministério Público na defesa de direitos difusos e coletivos, não se mostra adequado aplicar a mesma*

multa cominatória. Nesse contexto, impõe-se a revogação da multa aplicada. IV. DISPOSITIVO.Recurso provido, por unanimidade, para revogar a pena de multa aplicada pelo descumprimento da ordem judicial. _____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, § 1°.Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 03/08/2021; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03/04/2024, DJe 06/06/2024.(Agravo de Instrumento, Nº 51899575120258217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 18-09-2025)

Assim, o valor total da multa cominatória fica limitado ao valor da causa, R$ 162.240,00, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Dos danos morais:

No presente caso, a recusa de cobertura de tratamento médico essencial para doença grave, por si só, já ultrapassa o mero dissabor contratual, configurando conduta que atenta contra a dignidade da pessoa humana e gera aflição, angústia e incerteza que abalam o equilíbrio psíquico do indivíduo.

A demora no início do tratamento com o KESIMPTA®, causada diretamente pela recusa da ré e pelo subsequente descumprimento da ordem liminar, levou a uma piora objetiva e comprovada de seu quadro clínico.

O laudo de ressonância magnética do encéfalo, datado de 17/10/2023 (evento 9, LAUDO2), é contundente ao relatar o surgimento de "*cerca de 10 novas lesões hiperintensas*", com três delas apresentando "*impregnação pós-contraste sugerindo atividade inflamatória*".

O relatório médico de evento 36, LAUDO2 solicita a liberação urgente do medicamente, diante da possibilidade de risco de sequelas neurológicas graves e irreversíveis causadas por uma esclerose múltipla sem tratamento adequado.

A conduta da ré, portanto, não causou apenas um abalo psicológico, mas contribuiu ativamente para o agravamento físico da doença, com o surgimento de novas e irreversíveis lesões neurológicas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO TEMA 123 DO STF NÃO EXERCIDO. NOVO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE RECEBIDO COMO COMPLEMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL ANTERIOR. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO ART. 6º DA LINDB. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. NULIDADE POR OMISSÃO NO JULGADO NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ***DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO MÉDICO POR PARTE DA OPERADORA DE SAÚDE ENSEJA DANOS MORAIS NA HIPÓTESE DE AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO DE DOR, ABALO PSICOLÓGICO E DEMAIS PREJUÍZOS À SAÚDE JÁ FRAGILIZADA DO PACIENTE.*** *ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO.(Apelação Cível, Nº 50374244120148210001, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 12-08-2025) (grifei)*

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ***PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA****. AUTOR QUE POSSUI DIREITO A TRANSPORTE AEROMÉDICO. PROBLEMAS CARDÍACOS. TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL DE PORTO ALEGRE. DEMANDADA QUE NEGOU REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR DO INTERIOR (CARLOS BARBOSA) PARA PORTO ALEGRE. TRANSLADO QUE FORA REALIZADO DE FORMA PARTICULAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, SENDO ADIMPLIDO POR FAMILIARES. ABUSIVIDADE VERIFICADA. CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE QUE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA FORMA DA SÚMULA 608, DO STJ, DEVENDO SER INTERPRETADOS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE MAIS FRACA DESTA RELAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, IV, § 1°, II, DO CDC. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA DE REMOÇÃO DO PACIENTE, QUANDO COMPROVADAMENTE NECESSÁRIA, PARA OUTRO ESTABELECIMENTO HOSPITAL. ART. ART. 12, II, "E", DA LEI N° 9.656/98. DEVER DE RESSARCIR O CUSTEIO PELO TRANSPORTE.* ***DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CASO EM QUE SE MOSTRA EVIDENTES OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NA ESPÉCIE. CONDUTA DA DEMANDADA QUE COLOCA O PACIENTE/CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E IMPOTÊNCIA, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO À VIDA, CIRCUNSTÂNCIAS CAPAZES, POR SI SÓ, DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. CONDUTA DA RÉ QUE EXTRAPOLOU O SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, REPRESENTANDO UMA RECUSA INJUSTIFICADA E OFENSIVA QUE ENSEJOU CLARA VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DO DIREITO DE PERSONALIDADE DO AUTOR QUE, QUANDO NECESSITOU UTILIZAR DOS BENEFÍCIOS QUE SÃO ADIMPLIDOS, NÃO CONTOU COM A COBERTURA DO PLANO****. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 MANTIDO, POIS DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50003537820248210025, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Renan Alexandre Ioris, Julgado em: 05-11-2024) (grifei)*

Tendo em vista tais circunstâncias, bem como considerando que a parte autora é pessoa de parcos recursos e a ré é uma grande instituição, entendo como justa a fixação da indenização a título de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a parti da data da sentença (Súmula n.º 362 STJ) e acrescido de juros de mora, conforme Taxa Selic deduzidos o IPCA, a contar do evento danoso (Súmula n.º 52 do STJ).

Ante o exposto, a procedência dos pedidos é a medida que se impõe.

III. Dispositivo:

Ante do exposto, com base no art. 487, I, do CPC, julgo extinta a fase procedimental de conhecimento, com resolução de mérito, e **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial por **CAROLINA STRACK PADILHA** em face de **BRADESCO SAUDE S/A**, para:

a) **DECLARAR** a obrigação da ré em fornecer e custear integralmente o tratamento da autora com o medicamento **KESIMPTA® (ofatumumabe) 20 mg/0,4 mL**, conforme prescrição médica, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura. Fica registrado que o cumprimento direto desta obrigação pela ré tornou-se desnecessário, nos termos da fundamentação;

b) **CONDENAR** a ré ao pagamento da multa cominatória (astreintes) fixada na decisão do evento 38, DESPADEC1, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, incidente desde o término do prazo de 5 dias concedido na decisão até a data da efetiva comprovação do fornecimento do medicamento, cujo montante total fica limitado ao valor de R$ 162.240,00, a ser apurado em fase de liquidação de sentença e;

c) **CONDENAR** a parte ré ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a parti da data da sentença (Súmula n.º 362 STJ) e acrescido de juros de mora, conforme Taxa Selic deduzidos o IPCA, a contar do evento danoso (Súmula n.º 52 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento da taxa única e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversária, fixados em 10% do valor da condenação, considerando a natureza da demanda, o tempo de tramitação do feito e o trabalho realizado, com fundamento no que estabelece o artigo 85, § 2º, ambos do CPC.

Sentença registrada eletronicamente.

Intimadas as partes.

Transitado em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **JAQUELINE HOFLER, Juíza de Direito**, em 09/10/2025, às 10:41:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10092622955v21** e o código CRC **19cb6637**.